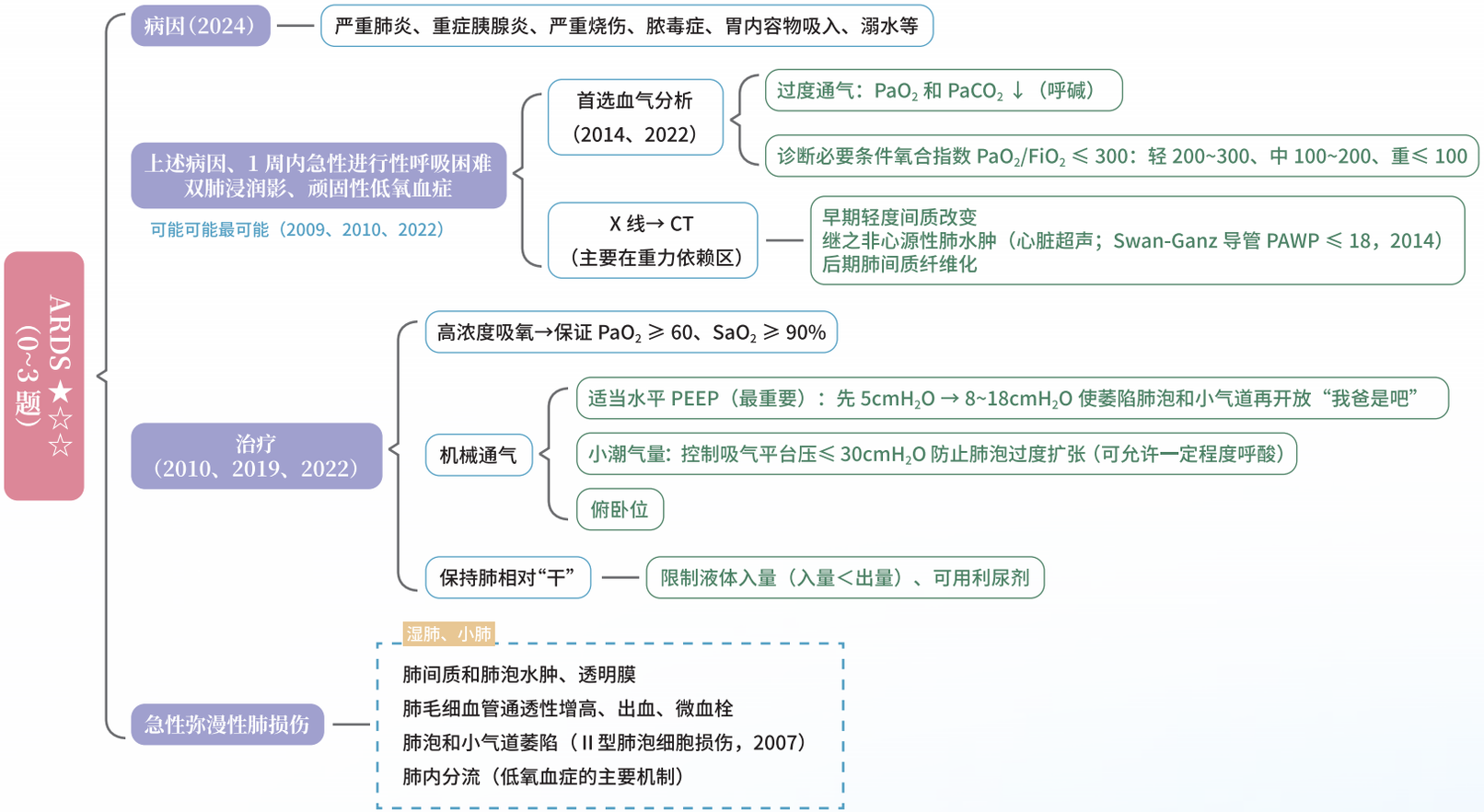

ARDS ★☆☆
（0~3 题）
病因（2024）
严重肺炎、重症胰腺炎、严重烧伤、脓毒症、胃内容物吸入、溺水等
上述病因、1 周内急性进行性呼吸困难
双肺浸润影、顽固性低氧血症
可能可能最可能（2009、2010、2022）
首选血气分析
（2014、2022）
过度通气：PaO_2 和 $PaCO_2$ ↓（呼碱）
诊断必要条件氧合指数 PaO_2/FiO_2 ≤ 300：轻 200~300、中 100~200、重≤ 100
X 线→ CT
（主要在重力依赖区）
早期轻度间质改变
继之非心源性肺水肿（心脏超声；Swan-Ganz 导管 PAWP ≤ 18，2014）
后期肺间质纤维化
治疗
（2010、2019、2022）
高浓度吸氧→保证 PaO_2 ≥ 60、SaO_2 ≥ 90%
机械通气
适当水平 PEEP（最重要）：先 5cmH_2O → 8~18cmH_2O 使萎陷肺泡和小气道再开放“我爸是吧”
小潮气量：控制吸气平台压≤ 30cmH_2O 防止肺泡过度扩张（可允许一定程度呼酸）
俯卧位
保持肺相对“干”
限制液体入量（入量＜出量）、可用利尿剂
急性弥漫性肺损伤
湿肺、小肺
肺间质和肺泡水肿、透明膜
肺毛细血管通透性增高、出血、微血栓
肺泡和小气道萎陷（Ⅱ型肺泡细胞损伤，2007）
肺内分流（低氧血症的主要机制）